

FAMERP | 2026

R1 ACESSO DIRETO

1 - Um trabalhador da área Metalúrgica apresentou no Exame Médico Periódico (NR-7) a chamada gota acústica, que mostrou o seguinte perfil audiométrico:

- A) Frequências 500-1.000 e 2.000, 4.000 e 6.000 Hz normais e 8.000Hz alterado.
- B) Frequências 500-1.000 e 2.000, 4.000 e 6.000 Hz alterado e 8.000Hz normal.
- C) Frequências 500-1.000, 2000 e 3.000 Hz normais, 4000 e 6000 Hz alterado e 8.000 Hz normal.
- D) Todas as Frequências 500-1.000 e 2.000 alterado 4.000 e 6.000 e 8.000 Hz normal.

2 - Nos Textos de História da Medicina do Trabalho, da lavra de autores brasileiros, é costume referir-se como "Pai da Medicina do Trabalho", inclusive quem padronizou a célebre pergunta ao trabalhador, que auxilia no diagnóstico das patologias relacionadas ao trabalho – "qual é a sua profissão?":

- A) Hipócrates.
- B) Bernardino Ramazzini.
- C) Sir Robert Backer.
- D) Bernardo Bedrikow.

3 - Uma trabalhadora da área Metalúrgica apresentou no Exame Periódico (NR-7), reação cutânea maculopapular, pruriginosa nas orelhas ao nível do orifício dos brincos, no punho ao usar relógio, ou relacionada com o botão metálico da calça jeans sugere dermatite de contato por:

- A) Níquel.
- B) Cromo.
- C) Zinco.
- D) Alumínio.

4 - Um Trabalhador da Área da Saúde (Enfermeiro) teve a sua Jornada de Trabalho Expirada às 18h, saindo A em sua motocicleta em direção à sua residência, quando lembrou-se de realizar as compras do mês em um supermercado que estava inserido no trajeto, tendo gasto aproximadamente 90 minutos para realizá-las. Dando início ao retorno para sua residência, sofre um acidente, sendo projetado ao solo, apresentando diversas faturas de Membros Superiores, pergunto:

- A) Não tenho elementos para caracterizar como Acidente de Trabalho.
- B) Caracteriza-se como Acidente do Trabalho de acordo com a Legislação Vigente.
- C) Caracteriza-se como acidente de Trânsito de acordo com a Legislação Vigente.

D) Tanto pode ser caracterizado como Acidente de Trânsito ou do Trabalho.

5 - No ano 1833, o primeiro inspetor Médico Robert Backer, durante a Revolução Industrial na Inglaterra (1760-1850) assinou o "*Factory Act*", cuja redação era seguinte:

- A) A idade mínima para o trabalho era de 6 anos.
- B) A idade máxima para o trabalho noturno será de 30 anos.
- C) Fica proibido o trabalho noturno para menores de 35 anos.
- D) A jornada de trabalho semanal será no mínimo de 69 horas.

6 - Ao realizar Exame Admissional de um Trabalhador da Área Metalúrgica que apresenta Nível de Pressão JA Sonora Elevado (Ruído) Médio de 115 decibéis, o E.P.I. (Equipamento de Proteção Individual), mais adequado a ser utilizado em uma Jornada de 40 horas semanais deve ser:

- A) Protetor Auricular tipo Concha.
- B) Protetor Auricular tipo de Inserção.
- C) Qualquer dos dois tipos de protetores de Inserção ou Concha.
- D) Não há necessidade para a utilização de protetor auricular.

7 - Plínio (23 a 79 D.C.), descreveu no ambiente nocivo das Minas de Carvão, Chumbo e Mercúrio, relatando que os trabalhadores utilizavam o Primeiro Equipamento de Proteção Individual (E.P.I.). descrito na literatura disponível. Qual foi o equipamento individual descrito:

- A) Botas do tipo Coturno.
- B) Membrana da bexiga do Carneiro.
- C) Avental de raspa de couro de animais.
- D) Camisa de Algodão com Manga Cumprida.

8 - Um trabalhador da área Rural durante o Exame Médico Periódico (NR-7) apresentou sintomas de VA intoxicação por Organofosforados. Identifique o provável Organofosforado:

- A) Acetilcolina.
- B) Ácido Mandélico.
- C) Ácido organo-fosfórico.
- D) Ácido delta aminolevulinico.

9 - Criança de 3 anos, masculino, apresentou febre de 38,5°C há 1 dia, tosse seca (inicialmente), coriza, conjuntivite não purulenta, com pequenos pontos brancos na boca na altura do último molar, com exantema que surgiu atrás das orelhas, no rosto e se espalhou pelo corpo. Foi à UPA, onde foi feita a suspeita de sarampo. Frequentou a Creche Municipal até o dia anterior ao início dos sintomas. Esta Creche atende crianças de 3 meses a 6 anos de idade e fica em um bairro com grande densidade populacional. A mãe refere que tem outra filha de 7 anos, que está em tratamento de leucemia linfóide aguda. Qual é a ação de vacinação, de acordo com a recomendação do Ministério da Saúde, no domicílio desta criança e na creche para interromper a circulação do vírus e controlar da transmissão do sarampo?

A) Deve ser realizada a vacinação por varredura, em até 48 horas, em todos os indivíduos suscetíveis maiores de seis meses e que residem nos quarteirões próximos da creche e nos quarteirões próximos do domicílio do caso suspeito (exceto nas contraindicações a aplicação da vacina, como a irmã de 7 anos com Leucemia que deve receber a Imunoglobulina humana inespecífica).

B) Deve ser realizada a vacinação de bloqueio com a Vacina Tríplice Viral (SCR), preferencialmente no prazo máximo de até 72 horas, para as crianças suscetíveis de 3 a 6 meses e gestantes (exceto nos indivíduos com contraindicações a aplicação da vacina).

C) Deve ser realizada a vacinação de bloqueio, em até 72 horas, em todos os indivíduos suscetíveis", que tiveram contato com o caso suspeito, a partir dos 6 meses de idade, sem limite de idade com a Vacina Tríplice Viral (SCR) (exceto nas contraindicações a aplicação da vacina, como a irmã de 7 anos com Leucemia que deve receber a Imunoglobulina humana específica).

D) Deve ser realizada a vacinação por varredura com a Vacina Tríplice Viral (SCR), no prazo máximo de até 48 horas, em todos os indivíduos suscetíveis de 3 meses até nove meses que frequentam as creches no bairro do caso suspeito bem como no seu domicílio (exceto nos indivíduos com contraindicações a aplicação da vacina).

10 - Menino de 15 anos, previamente hígido, procura atendimento na Unidade Básica de Saúde (UBS) referindo que há cerca de 30 min foi mordido por um gato de rua ao tentar retirá-lo de dentro da cozinha de sua avó idosa. As mordidas resultaram em lesões corto-contusas nas mãos, principalmente nos dedos, sendo mais intensas na mão direita atingindo polpas digitais. Paciente nega episódios anteriores de agressões desse tipo. O gato não pertence a ninguém da vizinhança e fugiu após a tentativa de ser capturado. Na localidade observou-se, no ano anterior, a confirmação de raiva em gatos. A conduta adequada no atendimento imediato ao paciente é:

A) Lavar os ferimentos com antissépticos; aguardar a busca ativa do animal, até 10 dias, pela zoonose para início da profilaxia; aplicar reforço da vacina dt (difteria e tétano) e fazer curativo diariamente.

B) Lavar os ferimentos com água corrente abundante e sabão; administrar a vacina antirrábica em 4 doses, nos dias 0, 3, 7 e 14; aplicar imunoglobulina humana antirrábica.

C) Higienizar adequadamente e suturar as lacerações; prescrever 1 dose de penicilina benzatina 1.2 milhão UI; aplicar o soro antirrábico; soro antitetânico e agendar curativos diários.

D) Higienizar com solução antisséptica; administrar a 1ª dose da vacina antirrábica; na presença de qualquer reação adversa, contraindicar as doses subsequentes; aplicar o soro antirrábico.

11 - Paciente com 53 anos, portador de asma, chega na Emergência do Hospital de Ensino com a história de febre de 38,5° C há 1 dia, tosse seca, dor de garganta, mialgia, cefaleia e prostração. Foi feito diagnóstico de Síndrome Gripal com identificação no painel de patógenos respiratórios do vírus Influenza. Qual a conduta correta para este caso?

A) Internar para solicitar a pesquisa de vírus respiratório pelo *Polymerase Chain Reaction* (PCR) e notificar no SINAN.

B) Prescrever antitérmico, colher exame para a pesquisa de vírus respiratório pelo *Polymerase Chain Reaction* (PCR) e retornar se dificuldade respiratória.

C) Internar para introduzir antibiótico macrolídeo injetável, pois a principal complicação de Síndrome Gripal em paciente com asma é a pneumonia.

D) Prescrever oseltamivir, preferencialmente nas primeiras 48h. Orientar o paciente a retornar se apresentar dificuldade respiratória.

12 - Homem 57 anos, tabagista, portador de dislipidemia, hipertensão arterial e obesidade. Reside sozinho em área onde a população é atendida pela Estratégia de Saúde da Família (ESF), porém não faz seguimento com a Equipe da ESF. Estava em sua casa quando apresentou intensa dor em região precordial iniciada há 24 horas, com piora progressiva, procurou o vizinho que chamou o SAMU e foi levado para a UPA. Deu entrada no serviço e evoluiu a óbito poucas horas após, sem resposta a manobras de reanimação. Eletrocardiograma da entrada na unidade evidenciou fibrilação ventricular. Em relação ao preenchimento da Declaração de Óbito deste caso a alternativa correta é:

ÓBITO DE MULHER EM IDADE FÉRTIL

☒ A morte ocorreu

☐ Na gravidez ☐ No parto ☐ No aborto

☐ De 47 dias a 1 ano após o término da gestação ☐ Não ocorreu nestes períodos

ASSISTÊNCIA MÉDICA

☒ Recebeu assist. médica durante a doença que ocasionou a morte? ☐ Não ☐ Ignorado

DIAGNÓSTICO CONFIRMADO POR:

☒ Necropsia? ☐ Sim ☐ Não ☐ Ignorado

Tempo aproximado entre o início da doença e a morte

CID

CAUSAS DA MORTE

PARTE I

Doença ou estado mórbido que causou diretamente a morte

CAUSAS ANTECEDENTES

Doenças, lesões, ou estados mórbidos, se existirem, que produziram a causa acima registrada, mencionando-se em último lugar a causa básica

ANOTE SOMENTE UM DIAGNÓSTICO POR LINHA

Devido ao como consequência de:

Devido ao como consequência de:

Devido ao como consequência de:

Devido ao como consequência de:

PARTE II

Outras condições significativas que contribuíram para a morte, as que não entraram, porém, na cadeia acima

A) Parte I:

- a. Fibrilação ventricular.
- b. Infarto agudo do miocárdio.
- c. Hipertensão arterial.

Parte II:

- d. Dislipidemia, tabagismo, obesidade.

B) Parte I:

- a. Infarto agudo do miocárdio.
- b. Aterosclerose coronariana.
- c. Fibrilação atrial.

Parte II:

- d. Dislipidemia, hipertensão arterial obesidade.

C) Parte I:

- a. Fibrilação ventricular.
- b. Infarto agudo do miocárdio.
- c. Aterosclerose coronariana.

Parte II:

- d. Dislipidemia, hipertensão arterial obesidade.

D) Parte I:

- a. Aterosclerose coronariana.
- b. Fibrilação atrial.
- c. Infarto agudo do miocárdio.

Parte II:

- d. Dislipidemia, hipertensão arterial obesidade.

13 - Mulher cisgênero, de 34 anos, procura atendimento em uma UBS (Unidade Básica de Saúde) do seu bairro, com seu médico de família, pois uma amiga descobriu recentemente um "câncer no útero". Chega em consulta solicitando diversos exames para investigação de câncer, pois está muito preocupada que possa ter algum problema grave de saúde, uma vez que não passa por qualquer avaliação há mais de 5 anos. Não tem comorbidades, é tabagista de 1 maço ao dia desde os 20 anos e tem IMC de 30,5 kg/m². Considerando as recomendações baseadas em evidências científicas assinale a alternativa que incorpore as investigações e exames corretamente indicados para a paciente:

- A) Tomografia de tórax de baixa dose; coleta de citopatologia oncótica; coleta de sorologia para HIV e sífilis.
- B) Coleta de citopatologia oncótica; aferição de pressão arterial; avaliação de perfil lipídico; avaliação de glicemia de jejum; coleta de sorologia para HIV e sífilis.
- C) Coleta de citopatologia oncótica; aferição de pressão arterial; avaliação de perfil lipídico; avaliação de glicemia de jejum; mamografia.
- D) Aferição de pressão arterial; coleta de citopatologia oncótica; solicitação de ultrassonografia transvaginal; coleta de sorologia para HIV e sífilis.

14 - Você é um médico de família e comunidade em uma UBS (Unidade Básica de Saúde) e o seu município enfrenta uma das piores epidemias de dengue dos últimos 20 anos. A unidade está com fluxo intenso de atendimentos. Considerando as fases clínicas da doença e a classificação dos grupos de risco, assinale a alternativa que elucida estratégia de acordo com o protocolo do Ministério da Saúde e que otimize recursos físicos e humanos diante de tal contexto epidemiológico. Leve em consideração apenas o manejo dos grupos A e B uma vez que grupos C e D serão referenciados para setor hospitalar:

- A) Coleta de hemograma e reavaliação diária para grupo B até 48h após remissão da febre; coleta de hemograma e reavaliação após 48h da remissão da febre para grupo A; reidratação oral.
- B) Coleta de hemograma e reavaliação diária para grupos A e B; hidratação endovenosa para os grupos A e B até 48h da admissão.
- C) Coleta de hemograma e reavaliação diária para grupos B até 48h após remissão da febre; hidratação endovenosa para os grupos A e B.
- D) Coleta de hemograma e reavaliação diária para grupos A e B até 48h após remissão da febre; reidratação oral disponível em sala de espera da UBS; hidratação endovenosa.

15 - O Programa Nacional de Imunização (PNI) recomenda as vacinas que devem ser administradas em gestantes a nível nacional. Dentre elas, preconiza-se a administração da vacina dTpa a partir da 20ª semana de gestação. A seguir, assinale a alternativa que elucida corretamente

o motivo dessa recomendação:

- A) A dose de reforço de dTpa nas gestantes é recomendada devido a imunossupressão fisiológica enfrentada durante o ciclo gravídico-puerperal.
- B) A dose de reforço de dTpa nas gestantes constitui estratégia em saúde pública, regulamentada pelo Ministério da Saúde, considerando o aumento de morbimortalidade materna em caso de difteria, tétano e coqueluche no ciclo gravídico-puerperal.
- C) A dose de reforço de dTpa nas gestantes é preconizada uma vez que imunizantes contra difteria, tétano e *B. pertussis* não são administrados em lactentes.
- D) A dose de reforço de dTpa nas gestantes aumenta a produção de anticorpos maternos e, portanto, constitui imunizante passivo aos lactentes contra difteria, tétano e *B. pertussis*, até que os mesmos sejam vacinados e adquiram imunidade ativa.

16 - Homem de 64 anos, diabético, em uso de metformina 1000 mg/dia, sem outras comorbidades, procura atendimento com sua médica de família e comunidade em sua UBS (Unidade Básica de Saúde) e queixa-se de cansaço, sonolência, boca seca, perda de peso e dificuldade para ter relações sexuais com a esposa. A médica revê o prontuário e identifica que o paciente tem exames do mês anterior com a única alteração sendo de sua hemoglobina glicada no valor de 14,5%. Em consultas anteriores a médica já havia captado que ele tem certa resistência ao uso da insulina, e quando retoma o assunto do resultado do exame, ele diz "insulina não, doutora, depois que minha finada mãe começou com a insulina, tudo desandou, fez até diálise!". Considerando o método clínico centrado na pessoa e as diretrizes clínicas para manejo de diabetes mellitus, assinale a alternativa que corresponde com a correta condução do caso:

- A) Explicar de forma acolhedora que as queixas trazidas estão relacionadas com a descompensação do diabetes mellitus e prescrever o uso de insulina NPH 0,5 U/kg.
- B) Explorar a experiência da doença e desmistificar equívocos quanto ao uso da insulina, compreender as ideias, sentimentos e expectativas da doença e do seu tratamento; pactuar em decisão compartilhada a introdução da insulina.
- C) Explorar a experiência da doença e a decisão compartilhada, respeitando definitivamente a decisão do paciente de não fazer uso de insulina. Registrar em prontuário, para respaldo, que o paciente está negando o tratamento proposto.
- D) Explicar ao paciente os efeitos deletérios da evolução da doença e otimizar tratamento farmacológico por meio de medicamentos via oral, acolhendo as angústias com tratamento por insulina; compartilhar o caso em reunião de equipe.

17 - Mulher de 36 anos de idade, trabalhadora na área de saúde pública, atendida no ambulatório de Ginecologia, irá fazer doutorado em outro país, está casada há dois anos e pretende engravidar após retornar ao país dentro de três anos. Refere a menarca aos 12 anos, ciclos menstruais regulares a cada 28/30 dias, fluxo menstrual de 5 dias, cólica menstrual de baixa intensidade, iniciou a vida sexual aos 20 anos, faz uso de preservativo masculino como método contraceptivo. Quais exames você solicitaria para fornecer as orientações à paciente?

- A) Dosagem de Estradiol e progesterona no terceiro dia do ciclo menstrual.

- B) Dosagem de TSH (Hormônio Tireoestimulante) e PRL (Prolactina) no terceiro dia do ciclo menstrual.
- C) Dosagem de FSH (Hormônio Folículo Estimulante) e HAM (Hormônio Antimülleriano) no terceiro dia do ciclo menstrual.
- D) Dosagem de ATGO (Anti-tireoglobulina) e HAM (Hormônio Antimülleriano) no terceiro dia do ciclo menstrual.

18 - Mulher, 55 anos, casada, G3 P3 partos normais, com vida sexual ativa, vem ao ambulatório de ginecologia com queixa de perda urinária continua pela vagina após ter sido submetida a histerectomia abdominal total por miomatose uterina. A conduta é:

- A) Iniciar com oxibutinina oral.
- B) Teste com injeção de azul de metileno intravesical.
- C) Encaminhar a paciente para estudo urodinâmico.
- D) Solicitar ultrassonografia vaginal e reavaliação após.

19 - Paciente de 28 anos, casada, atendida no serviço de emergência, refere usar de DIU (Dispositivo Intrauterino) de cobre há dois anos; apresentando alteração do fluxo menstrual nos últimos seis meses. Após a realização do exame físico ginecológico e ultrassom obstétrico, teve confirmada gestação de 16 semanas e, no exame especular, não foi visualizado o fio do DIU. A conduta médica correta é:

- A) Interromper a gestação.
- B) Deixar a gestação evoluir.
- C) Retirar o DIU instrumentalmente.
- D) Retirar o DIU e usar antibiótico profilático por 7 dias.

20 - Mulher 26 anos de idade, atendida na Unidade Básica de Saúde, refere que desde que menstruou a primeira vez aos 13 anos apresenta dores tipo cólica menstrual de forte intensidade, aos 16 anos de idade iniciou vida sexual e passou a usar contraceptivo hormonal oral com melhoras das dores. Devido diminuição da libido e cefaleia optou por parar com o uso do contraceptivo hormonal e está usando coito interrompido há oito meses. Porém as dores voltaram com aumento da intensidade, dificultando atividades laborais, passando a sentir dor à profundidade durante a relação sexual. Ao exame físico ginecológico, no toque vaginal observa-se a presença de útero em Retroversoflexão (RVF). com pouca mobilidade e doloroso com nodulações de consistência endurecida em região do fórnice vaginal posterior. Trouxe resultado de exame de ultrassom pélvico abdominal e endovaginal realizado há dois meses, porém esqueceu o laudo, tendo em mãos somente a imagem ao lado:



Qual a sua hipótese diagnóstica?

- A) Endometriose Peritoneal Profunda e Endometrioma Ovariano Bilateral.
- B) Síndrome do Ovários Policísticos com Microcistos Ovarianos Bilateral.
- C) Doença Inflamatória Pélvica com Abscesso Tubo Ovariano Bilateral.
- D) Dor Pélvica Aguda com Hidrossalpinge Bilateral.

21 - Mulher, 38 anos, nuligesta com desejo reprodutivo, procura ambulatório de ginecologia com queixa de aumento do volume do fluxo menstrual há 6 meses. A ultrassonografia pélvica endovaginal evidenciou dois nódulos de mioma, sendo o maior em parede uterina anterior de 2 x 3 cm (FIGO 1) e o menor com 1,5 x 2 cm (FIGO 4). Assinale a melhor alternativa para o tratamento definitivo do quadro:

- A) Curetagem uterina para remoção de leiomioma FIGO 4.
- B) Anti-inflamatório e ácido tranexâmico para controle do sangramento.
- C) Miomectomia do leiomioma FIGO 1 por histeroscopia cirúrgica.
- D) Propor tratamento com anticoncepcional combinado de uso contínuo.

22 - Paciente de 30 anos, G2 P2 (2 partos vaginais), procura Unidade Básica de Saúde por queixa de dor abdominal em baixo ventre há um mês e foi colhido seu primeiro exame de citologia cervical convencional. O resultado da citologia oncótica revelou uma lesão intraepitelial de alto grau de colo de útero (NIC 3). O próximo passo para o diagnóstico é:

- A) Colher PCR para HPV com genotipagem.
- B) Encaminhar para colposcopia e provável biópsia.
- C) Conização de colo de útero por cirurgia de alta frequência (CAF).
- D) Aguardar 6 meses e realizar nova coleta de citologia oncótica.

23 - Mulher adulta, de 28 anos de idade, procura atendimento na Unidade Básica de Saúde do seu município, referindo que não fez uso da vacina na adolescência, há seis meses notou o aparecimento de lesões verrucosas na vulva sendo diagnosticada como condiloma e passou por tratamento das mesmas. Ficou sabendo pelas amigas que tem clínicas particulares que fazem uma nova vacina contra HPV (Papiloma Vírus Humano). Qual a sua orientação para a paciente da imunização contra HPV na mulher adulta?

- A) Desconsiderar o uso da vacina por já ter iniciado vida sexual.
- B) Desconsiderar o uso da vacina por ter mais que 26 anos de idade.
- C) Considerar a vacinação contra HPV2-valente, na rede pública com esquema de duas doses (0-2 meses).
- D) Considerar a vacinação contra HPV9-valente, em clínicas particulares, esquema de três doses (0-2-6 meses).

24 - Uma adolescente de 16 anos de idade, acompanhada da sua mãe e da irmã de nove anos de idade, procura atendimento na Unidade Básica de Saúde do seu município. A jovem refere ter menstruado aos 12 anos de idade, apresenta ciclos regulares a cada 28 a 30 dias e com seis dias

de fluxo menstrual sem cólicas, sendo a última menstruação há 15 dias atrás. Informa que começou a namorar faz três meses, não teve relação sexual ainda, porém acredita que vai ter. Na aula de ciências, a professora orientou sobre o uso de vacina contra HPV (Papiloma Vírus Humano) na adolescência, porém a mãe não deseja vacinar nenhuma das filhas. Qual argumento abaixo está correto sobre a orientação do uso de vacina em adolescentes?

- A) A eficácia máxima da vacinação ocorre quando é aplicada antes do início sexual devido a produção de anticorpos que inativam o HPV intracelular.
- B) A eficácia máxima da vacinação ocorre quando é aplicada após o início sexual devido a produção de anticorpos que inativam o HPV intracelular.
- C) A eficácia máxima da vacinação ocorre quando é aplicada antes do início sexual devido a produção de anticorpos no líquido intercelular que inativam o HPV.
- D) A eficácia máxima da vacinação ocorre quando é aplicada após o início sexual e com parceiro infectado levando a produção de anticorpos que inativam o HPV intracelular.

25 - Primigesta, 24 anos, gestação de 38 semanas, em consulta num pronto atendimento obstétrico. Relata que há 4 horas está apresentando contrações uterinas dolorosas. Gestação de risco usual, fez pré-natal em uma Unidade Básica de Saúde. Exame físico geral: sem alterações. Exame obstétrico: altura uterina de 35 cm, batimentos cardíacos fetais normais, contrações uterinas presentes (3 contrações/30 seg/10 min), feto em apresentação cefálica, plano + 2 de De Lee, bolsa amniocorial íntegra e colo uterino dilatado em 6 cm. Realizada analgesia peridural. Além da internação, assinale a alternativa que contém as medidas mais apropriadas para a condução deste caso, durante este período clínico do parto:

- A) Realizar cardiotocografia, ausculta intermitente dos batimentos cardíacos fetais antes e avaliar a dilatação cervical a cada 2 horas.
- B) Avaliar as contrações de hora em hora, ausculta intermitente dos batimentos cardíacos fetais e verificar a dilatação cervical a cada 4 horas.
- C) Recomendar cardiotocografia contínua e o uso de ocitocina intravenosa, após realizar analgesia peridural.
- D) Orientar a paciente para realizar puxos dirigidos durante as contrações e administrar ocitocina por via endovenosa, se este período estiver prolongado.

26 - Gestante, 28 anos, G3P2 (cesáreas) A0, atualmente na 39ª semana é atendida no pronto socorro obstétrico em período expulsivo. Evolui sem intercorrências para parto por via vaginal. Após 30 minutos do nascimento, não ocorreu o secundamento. Realizado curagem, não ocorrendo o desprendimento placentário. O útero está contraído na cicatriz umbilical e não existem lacerações de trajeto. É indicado laparotomia exploradora de emergência. Qual a conduta mais adequada para esta paciente?

- A) Histerectomia puerperal com placenta in loco.
- B) Cirurgia de B-Lynch e posterior histerectomia.
- C) Retirada da placenta e posterior histerorrafia.
- D) Manobra da Taxe e procedimento de Huntington.

27 - Gestante, 28 anos, G3 P2 (partos por via vaginal), sem comorbidades. Está em sua primeira consulta na Unidade Básica de Saúde, assintomática, relatando um atraso menstrual de 18 semanas. Foi realizado ultrassom endovaginal onde foi observado feto com idade gestacional compatível com 13 semanas e ausência de batimentos cardíacos. A melhor conduta para esta paciente é:

- A) Aguardar expulsão fetal espontaneamente.
- B) Aspiração Manual Intrauterina (AMIU) e ocitocina.
- C) Curetagem uterina após expulsão fetal com misoprostol.
- D) Ocitocina por via endovenosa e curetagem uterina após expulsão fetal.

28 - Tercigesta, 24 anos, realiza suas consultas de pré-natal em ambulatório de alto risco, devido doença hemolítica perinatal na segunda gestação. Apresenta tipagem sanguínea Rh negativo e o esposo Rh positivo. Para a avaliação do grau de anemia fetal, qual exame deve ser solicitado:

- A) Cordocentese na 28ª semana de gestação e repetir na 36ª semana.
- B) Teste de Coombs indireto e dosagem espectrofotométrica da bilirrubina.
- C) Doppler da artéria cerebral média na 18ª semana e repetir semanalmente.
- D) Teste de Coombs indireto e cardiocotografia mensal até o momento do parto.

29 - Secundigesta, 24 anos, parto anterior de termo por via vaginal, sem intercorrências. É atendida na emergência obstétrica, com gestação de 36 semanas e queixa de perda de líquido por via vaginal há 6 horas. Exame físico geral sem anormalidades. Exame obstétrico: batimentos cardíacos fetais de 140/minuto, 4 contrações uterinas em 10 minutos de observação, líquido amniótico transparente fluindo do colo uterino, dilatação cervical de 8 cm, apresentação cefálica no plano 0 de De Lee. Qual a conduta mais adequada para esta paciente?

- A) Administrar sulfato de magnésio para neuroproteção fetal.
- B) Administrar corticoide para acelerar a maturidade pulmonar fetal.
- C) Realizar ultrassom para confirmar o diagnóstico de bolsa rota.
- D) Realizar ausculta fetal intermitente e aguardar o parto por via vaginal.

30 - Primigesta, 18 anos, idade gestacional de 38 semanas, gestação de risco usual, é internada em trabalho de parto. Exame físico geral sem alterações. Exame obstétrico: altura uterina de 35 cm, batimentos cardíacos fetais normais, 3 contrações de 30 segundos em 10 minutos de observação, colo uterino dilatado em 6 cm, apresentação cefálica, plano 0 de De Lee, bolsa íntegra. Exame cardiotocográfico: evidência linha de base da frequência cardíaca fetal de 140 bpm, variabilidade moderada, presença de acelerações transitórias e desacelerações precoces. De acordo com estes dados, assinale a alternativa correta que contém, respectivamente, a classificação do exame cardiotocográfico e a conduta:

- A) Categoria I, traçado da FCF normal; conduzir de maneira habitual, com ausculta da FCF de 30/30 minutos no 1º estágio e 15/15 minutos no 2º estágio.
- B) Categoria II, traçado indeterminado da FCF; requer acompanhamento com ausculta da FCF contínua, perfil biofísico fetal e dopplervelocimetria.

C) Categoria III, traçado anormal; requer medidas de ressuscitação intrauterina e resolução da gestação.

D) Não reativa; continuar a avaliação da FCF durante 40 minutos e, não melhorando, realizar medidas de ressuscitação intrauterina.

31 - Primigesta, 18 anos, gestação de 24 semanas, em consulta na UBS devido lesões na região vulvar. Feito diagnóstico de herpes genital, sendo tratada com Aciclovir por via oral. A paciente deseja realizar parto por via vaginal. Para evitar a transmissão vertical, em qual fase da gestação deve ser realizada a terapia supressiva com aciclovir?

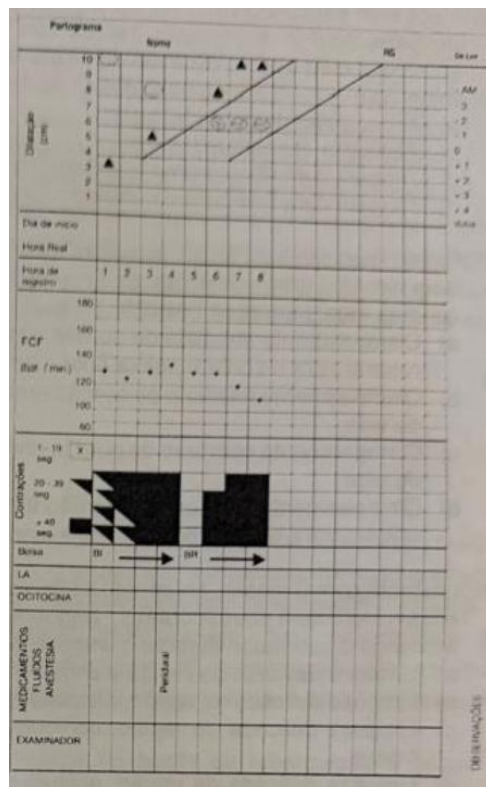
A) Da 20ª semana até a 36ª semana.

B) Da 28ª semana até a 36ª semana.

C) Da 28ª semana até o momento do parto.

D) Da 36ª semana até o momento do parto.

32 - Primigesta, 28 anos, pré-natal de risco usual, internada em trabalho de parto com gestação de termo. A evolução do trabalho de parto está demonstrada no partograma abaixo:



Após realizar diagnóstico de parada secundária da descida, qual a etiologia e a melhor conduta?

A) Distocia de rotação e fórceps de Kielland

B) Desproporção cefalopélvica e operação cesariana.

C) Desproporção cefalopélvica e rotação manual da apresentação.

D) Distocia da variedade de posição e posição materna verticalizada.

33 - Recém-nascido (Rn) termo está com 10 dias de vida, em aleitamento materno exclusivo, com

bom ganho ponderal, diurese e evacuação presentes. Ao exame físico encontra-se icterício zona II de Kramer. Qual deve ser sua conduta neste momento:

- A) Manter aleitamento materno e investigar colestase.
- B) Manter aleitamento materno e investigar doença hemolítica.
- C) Manter aleitamento materno e reavaliar icterícia em 5-7 dias.
- D) Iniciar fórmula infantil e reavaliar icterícia em 5-7 dias.

34 - Recém-nascido (Rn) termo de 37 3/7 semanas de parto cesárea por descontrole glicêmico, sexo masculino, APGAR 7/8 e peso de nascimento de 2970 g. Evoluiu com desconforto respiratório precoce e necessitou de internação em UTI Neonatal em uso de CPAP. Após 4 horas de internação evoluiu com piora súbita do padrão respiratório e queda de saturação O₂. Qual a principal hipótese diagnóstica neste momento:

- A) Pneumotórax.
- B) Cardiopatia congênita canal dependente.
- C) Taquipneia transitória do Recém-nascido.
- D) Síndrome do Desconforto Respiratório Grave.

35 - Recém-nascido (Rn) de 36 1/7 semanas, nascido de parto normal, sem intercorrências, pesando 2110 g (percentil 5 da curva de peso/estatura – Intergrow21). Quais as classificações corretas deste paciente:

- A) Rn pretermo tardio, adequado para idade gestacional e baixo peso.
- B) Rn pretermo tardio, pequeno para a idade gestacional e baixo peso.
- C) Rn pretermo, pequeno para a idade gestacional e muito baixo peso
- D) Rn pretermo, pequeno para a idade gestacional e baixo peso.

36 - Você está passando visita no alojamento conjunto em um recém-nascido a termo e mãe com história de Sífilis durante a gestação tratada com 3 doses de penicilina benzatina e queda da titulação da sorologia, com último resultado de VDRL de 1: 4. Rn está assintomático, com boa aceitação de seio materno e com VDRL no nascimento de 1: 4. Qual deve ser a sua conduta frente a esse paciente:

- A) Acompanhamento ambulatorial.
- B) Penicilina benzatina dose única.
- C) Triagem com hemograma e radiografia de ossos longos.
- D) Triagem com hemograma, radiografia de ossos longos e líquido.

37 - Recém-nascido com 35 2/7 semanas nascido de parto normal com choro forte e bom tônus muscular. Segundo as últimas diretrizes da Sociedade de Pediatria e do Programa de Reanimação Neonatal, a conduta ideal para esse paciente será:

- A) Clampeamento imediato de cordão umbilical, levar para a fonte de calor radiante, estabilização e retorno para o contato pele a pele e amamentação na primeira hora de vida.

- B) Clampeamento imediato de cordão umbilical, contato pele a pele e amamentação na primeira hora de vida.
- C) Clampeamento oportuno de cordão umbilical, contato pele a pele e amamentação na primeira hora de vida.
- D) Clampeamento oportuno de cordão umbilical, levar para a fonte de calor radiante, estabilização e retorno para o contato pele a pele e amamentação na primeira hora de vida.

38 - Lactente com 9 meses, apresenta lesão eritematosa, com pequenas pústulas e áreas de descamação em períneo, sem poupar dobras. Segundo a mãe, as lesões surgiram há mais ou menos 1 semana e a criança chora muito durante a limpeza da região. Qual o melhor tratamento para esse paciente:

- A) Limpeza delicada da região e creme de barreira intercalando as trocas.
- B) Limpeza delicada da região, nistatina tópica por 14 dias e creme de barreira intercalando as trocas.
- C) Limpeza delicada da região, corticoide tópico por 14 dias e creme de barreira intercalando as trocas.
- D) Limpeza delicada da região, antibiótico tópico por 14 dias e creme de barreira intercalando as trocas

39 - Menino de 6 anos apresenta, há 4 dias, *rash* eritematoso caracterizado por lesões purpúricas elevadas, não pruriginosas e que não somem à digitopressão. As lesões iniciaram-se de forma esparsa em ambos os pés, progredindo proximalmente para as coxas e extremidades superiores, com acometimento também de palmas e plantas. Hoje, evoluiu com edema doloroso em pés, limitando a deambulação, além de dor abdominal difusa, mais intensa nos quadrantes superiores direito e esquerdo, de caráter cólico, exacerbada pela alimentação. Nega diarreia, sangramento digestivo, febre ou outros sintomas sistêmicos. É previamente hígido, nega uso habitual de medicações. Refere uso de claritromicina há cerca de 14 dias para quadro respiratório. Hemograma realizado em serviço de emergência não apresenta citopenias ou outras alterações significativas. Considerando a principal hipótese diagnóstica, qual dos seguintes exames é o mais relevante para complementar a avaliação do quadro clínico deste paciente?

- A) Angiotomografia torácica e abdominal.
- B) Pesquisa de leucócitos fecais e angiotomografia abdominal.
- C) Biópsia cutânea com imunofluorescência ou imuno-histoquímica.
- D) Urina 1 (exame de sedimento urinário), dosagem sérica de ureia e creatinina

40 - Menina de 07 anos de idade previamente hígida, é admitida no hospital com febre, tosse, queda do estado geral, inapetência e dor abdominal de início há três dias. À radiografia de tórax notou-se área de opacidade em terço médio-inferior esquerdo, com obliteração do seio costofrênico esquerdo e sinal do menisco. A propedêutica pulmonar esperada ao exame físico dessa criança é:

- A) Expansibilidade pulmonar diminuída no hemitórax esquerdo, frêmito toracovocal e murmúrio vesicular diminuídos em terço médio-inferior esquerdo.

- B) Expansibilidade pulmonar diminuída no hemitórax esquerdo, frêmito toracovocal aumentado e murmúrio vesicular diminuído em terço médio-inferior esquerdo.
- C) Expansibilidade pulmonar diminuída no hemitórax esquerdo, frêmito toracovocal diminuído com murmúrio vesicular presente bilateralmente.
- D) Expansibilidade pulmonar diminuída no hemitórax esquerdo, frêmito toracovocal aumentado e murmúrio vesicular abolido em terço médio-inferior esquerdo.

41 - Criança de 3 anos, feminino, vem apresentando resfriados recorrentes caracterizados por coriza espirros, congestão e prurido nasal, que evoluem às vezes com muita tosse e chiado no peito. Mãe relata que os episódios se iniciaram depois que começou a frequentar creche aos 8 meses de idade e nos últimos meses vem notando que a criança faz um barulho estranho no peito e tem crise de tosse quando dá gargalhada ou chora muito. De antecedentes pessoais, refere episódio de Bronquiolite viral aguda grave aos 9 meses, com necessidade de hospitalização e suporte ventilatório, com painel viral positivo para rinovírus. Refere ainda que há um mês teve que procurar a UPA porque teve crise intensa de tosse e ficou com respiração ofegante, mas melhorou rapidamente após a administração de doses de Salbutamol em spray. Mãe relata que passou por pediatra especialista em doenças respiratórias que não observou alterações ao exame físico e solicitou exames investigatórios que estavam normais. O diagnóstico clínico mais provável é:

- A) Asma persistente.
- B) Bronquiolite obliterante.
- C) Discinesia ciliar primária.
- D) Síndrome do bebê chiador.

42 - Menina de 6 anos, há 15 dias apresentando tosse, adinamia e anorexia, evoluindo nos últimos quatro dias com febre baixa e com piora clínica progressiva. Foi iniciado Ceftriaxona endovenosa na origem e transferida hospital de referência. À radiografia de tórax evidenciado consolidação extensa a esquerda, com pequeno derrame pleural. Foi realizado toracocentese, sem necessidade de drenagem pleural. Recebeu dois esquemas antibióticos amplos para germes comuns e atípicos durante o período de 15 dias, evoluindo sem melhora clínico-radiológica. A conduta adequada para essa paciente é:

- A) Realizar exame do escarro para identificar a presença do bacilo da tuberculose e iniciar o tratamento somente se o resultado for positivo.
- B) Iniciar o tratamento da tuberculose se a prova tuberculínica mostrar uma reação na pele de 10 mm ou maior, pois nesse caso o diagnóstico é muito provável.
- C) Manter esquema antibiótico ampliado e investigar imunodeficiência devido à falta de resposta a antibioticoterapia prolongada.
- D) Realizar uma tomografia de tórax para avaliar a extensão da pneumonia e do derrame pleural e a indicação de toracocentese.

43 - Menina de 8 anos, com diagnóstico recente de leucemia linfoblástica aguda, em tratamento no primeiro ciclo de quimioterapia, apresenta perda de consciência, apneia e ausência de pulso central palpável. O monitor cardíaco demonstra fibrilação ventricular. Reanimação cardiorrespiratória iniciada. Em relação às drogas que podem ser administradas durante a

reanimação cardiopulmonar podemos afirmar:

- A) A amiodarona deve ser utilizada após o terceiro choque.
- B) A lidocaína deve ser administrada após o primeiro choque.
- C) Está indicada a cardioversão elétrica sincronizada desde o primeiro ciclo de reanimação.
- D) A adrenalina deve ser usada precocemente no primeiro ciclo de reanimação, pois melhora o prognóstico.

44 - Na manutenção hídrica do paciente criticamente enfermo não deve ser utilizada solução hipotônica. Um dos principais mecanismos que causam esta complicação é a Secreção Inapropriada do Hormônio Antidiurético (ADH). Qual das alternativas abaixo contém a característica clínico-laboratorial da SIADH:

- A) Hipernatremia euvolemica.
- B) Hiponatremia hipovolêmica.
- C) Hiponatremia euvolêmica.
- D) Hipernatremia hipovolêmica.

45 - Você está de plantão na emergência pediátrica de um Hospital Infantil e recebe um paciente, sexo masculino, 10 anos com história de vômitos e dor abdominal há 3 dias. Na avaliação sistemática você identifica uma criança extremamente desidratada, com a seguinte avaliação:

- FC: 110 bpm;
- FR: 48 irpm;
- Saturação O₂: 98% ar ambiente;
- PA: 110x70 mmHg;
- Sem sinais de desconforto respiratório, pulsos amplos e simétricos;
- Glicemia capilar: 350;
- Sódio: 137;
- Cloro: 92;

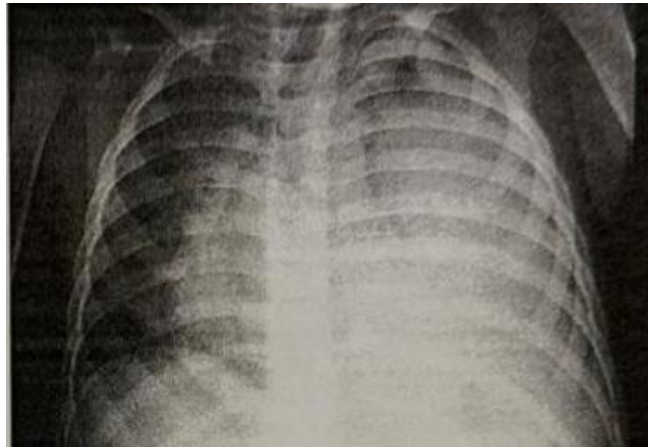
Gasometria venosa:

- pH: 7,35;
- pO₂: 86;
- pCO₂: 30;
- Bicarbonato de sódio: 18;
- BE: -10;
- Saturação O₂: 78%.

Qual distúrbio ácido-básico presente?

- A) Acidose metabólica hiperclorêmica.
- B) Alcalose metabólica hiperclorêmica.
- C) Acidose metabólica ânion gap aumentada e o AG é de 30.
- D) Acidose metabólica de ânion gap aumentado e o AG é de 47.

46 - Pré-escolar, 6 anos de idade internado na unidade de internação pediátrica do hospital, com diagnóstico de pneumonia adquirida na comunidade. Encontra-se hemodinamicamente estável em cateter nasal de baixo fluxo 1 L/min. O raio-X encontra-se abaixo:



Qual o principal agente etiológico e o esquema preferencial de tratamento?

- A) *Staphylococcus aureus*, Oxacilina.
- B) *Staphylococcus aureus*, Vancomicina.
- C) *Streptococcus cristalina pneumoniae*, Penicilina.
- D) *Streptococcus pneumoniae*, Ceftriaxona associado a oxacilina

47 - A febre é uma das principais queixas nos departamentos de emergências pediátricas. Na avaliação de um paciente com febre sem sinais localizatórios com idade entre 1 a 3 meses, a definição entre alto e baixo risco de uma infecção bacteriana grave depende dos seguintes exames:

- A) Hemograma, urinálise.
- B) Hemograma, coprocultura e liquor.
- C) Hemograma, hemocultura, urinálise.
- D) Hemograma, urinálise, liquor e raio-X de tórax.

48 - Paciente gestante com quadro de artrite reumatoide que faz uso de rituximab como forma de controle de sua doença durante a gestação sendo a última dose realizada 2 semanas antes no nascimento. O Rn nasce a termo, APGAR 9/10, Peso de nascimento 2500 gramas, parto normal. Com relação à vacina hepatite B e a vacina BCG, assinala a alternativa correta com relação as mesmas:

- A) Contraindicar a hepatite B e BCG.
- B) Dar a vacina hepatite B e adiar por 3 meses a BCG.
- C) Dar a vacina da hepatite B e adiar a BCG por 8 meses.
- D) Dar a vacina hepatite B e contraindicar a BCG por 12 meses.

49 - Paciente de 75 anos, gênero feminino, é trazida à unidade de emergência hospitalar por quadro de desorientação no tempo e espaço há 6 horas. Exames complementares colhidos encontram-se dentro da normalidade exceto por Na = 118 mEq/L. Uma vez que tenha sido optada

pela prescrição de solução salina a 3%, qual deve o objetivo de variação da natremia desta paciente?

- A) 4 a 6 mEq rapidamente.
- B) 8 a 12 mEq em 24 horas.
- C) 6 a 8 mEq em 36 horas.
- D) 8 a 10 mEq em 48 horas.

50 - Paciente de 45 anos, gênero feminino, é admitida em unidade de emergência por quadro de tetraparesia flácida que progrediu de perda de força motora ao longo de 7 dias. Desconhecia comorbidades e não fazia uso de medicações regularmente. Exames laboratoriais evidenciaram:

- $K = 2,2 \text{ mEq/L}$;
- $Na = 135 \text{ mEq/L}$;

Gasometria venosa:

- $pH = 7,25$;
- $HCO_3 = 18$;
- $pCO_2 = 26$;
- $Cl = 105 \text{ mEq/L}$;
- $Ca = 9,9$;
- Creatinina = $1,0 \text{ mg/dL}$;

Hemograma sem alterações e urina I:

- Densidade = 1015;
- $pH = 7,0$;
- Leucócitos = 2.000 hemácias;
- Proteínas e cilindros ausentes.

Diante deste quadro, qual é o diagnóstico mais provável?

- A) Amiloidose.
- B) Mieloma múltiplo.
- C) Síndrome de Sjogren.
- D) Doença de Addison.

51 - Paciente de 38 anos, gênero masculino, é admitido em unidade de emergência por rebaixamento do nível de consciência sucedido por crises convulsivas há 6 horas. Não apresenta déficits sensitivos ou motores. Exames complementares evidenciaram:

- Calcemia total = $13,5 \text{ mg/dL}$ (VR: 8,8 a 10,2);
- PTH = 8 pg/mL (VR = 15 a 65);
- $1,25(OH)_2$ vitamina D = 120 pg/mL (VR = 18 a 72);
- $25(OH)$ vitamina D = 28 ng/mL (VR = 30 a 60).

Qual, dentre as abaixo, seria a possibilidade diagnóstica mais provável?

- A) Linfoma.
- B) Amiloidose.
- C) Neoplasia produtora de PTHrp.
- D) Intoxicação de coledaliferol.

52 - Paciente de 65 anos, gênero feminino, retorna à consulta ambulatorial para seguimento do seu tratamento de artrite reumatoide em uso exclusivo dos metotexate. Está apresentando queixa recorrente de astenia. Exames complementares evidenciaram:

- Hemograma:
 - Hb = 8,8 g/dL;
 - VCM = 78 fl;
 - HCM = 30 pg;
 - Leucócitos = 8.500;
 - Plaquetas = 230 mil;
 - Ferritina = 650 ng/mL (VR: 20 a 300);
 - Capacidade total de ligação do ferro = 150 ug/dL (VR: 250 a 400).

Qual é o provável mecanismo da anemia da paciente?

- A) Hemólise.
- B) Ferroopenia.
- C) Deficiência de folato.
- D) Aumento de hepcidina.

53 - Paciente de 65 anos, gênero masculino, está internado na enfermaria de clínica médica para investigar volumoso derrame pleural em hemitórax direito visto no raio x de tórax, solicitado por queixa de dispneia progressiva há 2 semanas, com ortopneia e trepopneia. Paciente desconhece comorbidades, não faz uso de medicações e nega tabagismo ou etilismo. Foi realizada toracocentese diagnóstica com seguintes achados:

- aspecto amarelo-âmbar;
- DHL = 180 U/I;
- Proteínas totais = 5,8 g/dL;
- Celularidade com:
 - 38% de neutrófilos;
 - 30% de linfócitos;
 - 32% de monócitos.
- ADA = 18 U/I;
- Glicose = 60 mg/dL;
- pH = 7,5.

Exames séricos colhidos conjuntamente à toracocentese:

- DHL = 240 U/I (VR: 125 a 250);
- Proteínas totais = 7,5 g/dL (VR: 6 a 8,3);
- Albumina = 4,0 g/dL.

Diante deste quadro, qual é a hipótese diagnóstica mais provável?

- A) Tuberculose.
- B) Neoplasia.
- C) Pneumonia.
- D) TEP.

54 - Paciente de 78 anos, gênero masculino, retorna ao ambulatório de clínica médica para seguimento do seu tratamento de hipertensão reportando recorrentes episódios de vertigem, em especial ao se levantar. Ao exame físico apresenta PA sentada = 120x72 mmHg e PA em pé = 98x60 mmHg. Está em uso regular de enalapril 10 mg/dia, hidroclorotiazida 25mg/dia e anlodipina 5 mg/dia. Diante deste quadro qual seria a melhor conduta?

- A) Aumentar sal da dieta.
- B) Suspende anlodipina.
- C) Suspende hidroclorotiazida.
- D) Substituir o enalapril por losartan.

55 - Paciente de 69 anos, gênero masculino, encontra-se internado em enfermaria por descompensação de cirrose por álcool com ascite volumosa. Foi iniciado tratamento com furosemda e espironolactona após realização de paracentese cujo resultado evidenciou albumina = 1,1, proteínas totais = 2,2 g/dL, neutrófilos = 200/mm³ e cultura negativa. No 3º dia de internação evoluiu com alteração do ciclo sono- vigília e achado de *flapping* no exame físico. Qual possível achado laboratorial ou condição clínica, dentre os abaixo, pode ter contribuído para evolução clínica do paciente?

- A) Hipercalcemia.
- B) Hipocalemia.
- C) Acidose metabólica.
- D) Peritonite Bacteriana Espontânea.

56 - Paciente de 38 anos, gênero feminino, procura atendimento ambulatorial após realizar Ultrassom de tireoide feito pelo histórico familiar de carcinoma papilífero com evidência de nódulo tireoidiano de 0,9x0,7x0,6cm, em lobo esquerdo, TIRADS 5. Clinicamente está assintomática. Qual deve ser a conduta correta neste momento?

- A) Cintilografia de tireoide.
- B) PAAF guiada por US.
- C) Dosagem de TSH.
- D) Ultrassom anual.

57 - Paciente de 40 anos procura atendimento médico pois deseja emagrecer. Não apresenta queixas clínicas e seus exames de glicemia e perfil lipídico encontram-se dentro da faixa de referência. Nega outras comorbidades ou fármacos em uso regular. Ao exame físico apresenta PA = 120 * 80 e os seguintes dados antropométricos: Altura = 1,70 m, peso 89,59 kg (IMC = 31),

circunferência abdominal = 108 cm , circunferência de quadril = 95 cm. Levando-se em conta estes dados de exame físico e a história clínica e a nova proposta de avaliação diagnóstica para obesidade como podemos definir este paciente?

- A) Sobrepeso.
- B) Obesidade grau 1.
- C) Obesidade clínica.
- D) Obesidade pré-clínica.

58 - Paciente de 22 anos, gênero feminino, procura atendimento ambulatorial para investigar quadro de astenia progressiva nos últimos 3 meses associado a oligomenorreia e episódios de dores abdominais difusas. Dentre as possibilidades diagnósticas foi pensado em doença celíaca. Considerando esta hipótese qual deveria ser o plano terapêutico?

- A) Solicitar anticorpo anti-transglutaminase IgA e IgA total.
- B) Solicitar anticorpo anti-endomísio IgA e anticorpo anti-gliadina IgG.
- C) Solicitar pesquisa HLA DQ2 ou DQ8 se auto-anticorpos negativos.
- D) Solicitar pesquisa HLA DQ2 ou DQ8 e endoscopia digestiva com biopsia.

59 - Paciente de 81 anos, gênero masculino, comparece em consulta ambulatorial para seguimento de hipertensão e dislipidemia. Faz uso regular de hidroclorotiazida 25 mg/dia, losartan 50 mg/dia e rosuvastatina 10 mg/dia. Não traz novas queixas à consulta. Ao exame físico: PA = 130x70, peso corporal = 60 kg, altura 170 cm, sem alterações significativas cardiovasculares ou respiratórias. Exames de rotina dentro dos parâmetros de referência exceto por TSH = 7,5 mUI/I (VR: 0,5 a 4,5). Diante deste caso, qual deve a conduta com relação à abordagem do resultado do TSH?

- A) Expectante.
- B) Aguardar ultrassom de tireoide.
- C) Introduzir levotiroxina 1,5mcg/kg.
- D) Introduzir levotiroxina 25mcg/dia.

60 - Homem, 80 anos, internado na enfermaria de Clínica Médica devido dispneia a pequenos esforços. ortopneia e edema de membros inferiores. Exames laboratoriais revelaram hemoglobina de 13 g/dL, creatinina 1,2 mg/dL com presença de proteinúria. Eletrocardiograma evidencia ritmo de fibrilação atrial, sem outras alterações. Ecocardiograma mostra função ventricular esquerda normal, com espessamento de septo e parede posterior (14 mm). Ressonância magnética cardíaca mostra realce tardio subendocárdico difuso. Para prosseguir a investigação diagnóstica, qual seria a conduta mais adequada?

- A) Solicitação de cintilografia miocárdica com pirofosfato.
- B) Solicitação de imunofixação sérica e urinária e dosagem de cadeias leves livres.
- C) Realização de ultrassom de rins e vias urinárias seguida de biópsia renal diagnóstica.
- D) Realização de mielograma com biopsia de medula óssea.

61 - Paciente Masculino, 63 anos, diabético e hipertenso, submetido à colectomia esquerda eletiva

(neoplasia de cólon esquerdo). Devido à hemorragia acidental, a perda sanguínea estimada foi de 2300 mL e o tempo cirúrgico se estendeu por 6 horas. Admitido em UTI para cuidados pós-operatórios sob analgossedação, ventilação mecânica invasiva e uso de noradrenalina 0,3 mcg/kg/min. Cateter venoso central em veia jugular interna direita, linha arterial em artéria radial direita, mantido com colostomia e dreno de vigilância abdominal. Os dados hemodinâmicos referentes às 4 primeiras horas em UTI estão representados abaixo:

	Admissão	2ª hora	4ª hora
FC (bpm)	85	110	125
PAS/PAD (mmHg)	120/70	110/60	100/55
Diurese (ml/kg/h)	-	0,5	0,2
PVC (mmHg)	12	7	4
Sat central O ₂ (%)	79	60	58
P(v-a) CO ₂ (mmHg)	6	7	10

Qual seria a conduta mais adequada?

- A) Otimização de vasopressor, introdução de inotrópico, contactar cirurgião para avaliar reabordagem cirúrgica.
- B) Expansão volêmica com solução cristaloide, iniciar furosemida endovenosa para estímulo diurético e controle de glicemia.
- C) Expansão volêmica com solução cristaloide, avaliar necessidade de transfusão de hemocomponentes e otimização de vasopressor.
- D) Expansão volêmica com solução coloide, avaliar necessidade transfusão de hemocomponentes e solicitar a presença do cirurgião.

62 - Um paciente masculino de 45 anos, recentemente internado num leito de UTI, tem diagnóstico síndrome de choque. Foi submetido à passagem de cateter de Swan-Ganz. As medidas realizadas evidenciam: pressão capilar pulmonar ocluída reduzida, débito cardíaco normal, pressão venosa central reduzida e resistência vascular sistêmica reduzida. Com base nesses achados, esse paciente apresenta que tipo de choque?

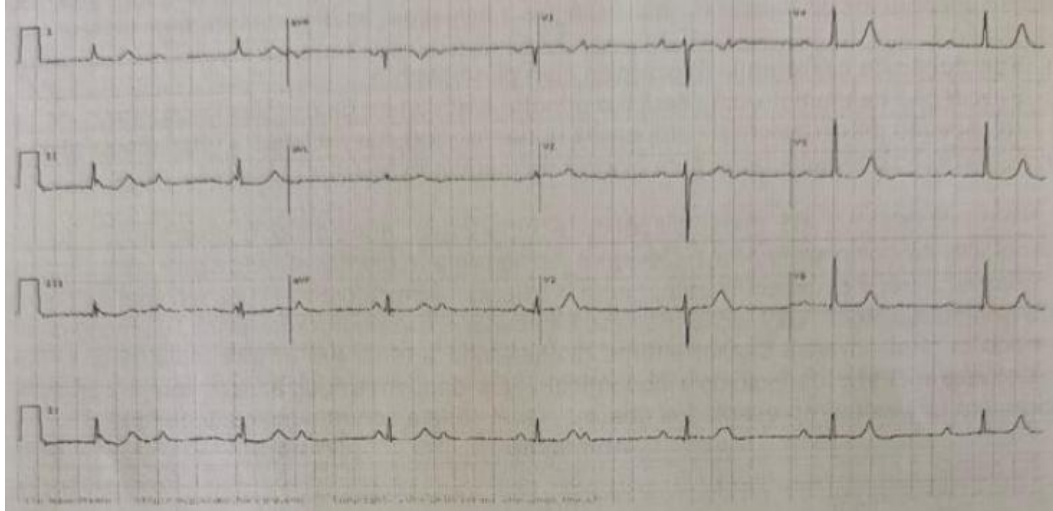
- A) Obstrutivo.
- B) Distributivo.
- C) Hipovolêmico.
- D) Cardiogênico.

63 - Masculino, 25 anos, é admitido no pronto atendimento de emergência, apresenta quadro de alteração do estado mental há 01 semana, caracterizada como comportamento inadequado, com agressividade e agitação. Ontem, apresentou quadro de parada da contactuação com duração de alguns segundos, acompanhada de liberação esfinteriana. Previamente é tabagista importante, não usa medicações continuamente. Ao exame físico, FC: 101 bpm, PA: 120×80 mmHg, Glasgow 14 (confuso), dextro 81, sem déficits neurológicos focais, sinal de Kerning e Brudzinski negativos. Nos exames iniciais de emergência, laboratoriais séricos sem alterações significativas e tomografia de crânio dentro da normalidade. Qual conduta seria a mais adequada neste momento:

- A) Coleta de líquido.
- B) Cintilografia Cerebral.

- C) Ressonância de Crânio.
- D) Avaliação da Psiquiatria.

64 - Paciente 59 anos, portador de estenose mitral moderada, é internado na enfermaria de Clínica Médica com diagnóstico de endocardite infecciosa de valva mitral (vegetação confirmada ecocardiograma), em uso de ceftriaxona e vancomicina (empiricamente, aguardando resultado de culturas). No 3º dia de internação evolui com palidez cutânea, hipotensão, bradicardia, com o seguinte eletrocardiograma.



Sobre o caso assinale o diagnóstico e a conduta mais adequados:

- A) Trata-se de um Bloqueio Atrioventricular (BAV) 2:1, esperado nos quadros de endocardite e geralmente com resolução espontânea.
- B) Trata-se de Bloqueio Atrioventricular Total (BAVT), mas neste caso não é indicada a colocação de marcapasso temporário, pois há risco de embolização séptica.
- C) Trata-se de Bloqueio Atrioventricular Total (BAVT) por possível abscesso valvar, sendo indicado marcapasso temporário e cirurgia de troca valvar de urgência.
- D) Trata-se de Bloqueio Atrioventricular (BAV) de 1º grau, sendo indicada observação em leito de terapia intensiva.

65 - Sexo masculino, 16 anos, sem comorbidades, faz uso inadvertido de diclofenaco sódico devido a dores musculares frequentes após treinos em academia. Dá entrada na emergência cirúrgica devido à queda no banheiro há 12 horas, apresentando sinais de traumatismo cranioencefálico leve. Está consciente e orientado, tem pequeno ferimento corto-contuso em supercílio direito, sem necessidade de sutura, pálido 2+/4+. Sinais vitais: PA = 80x40 mmHg, FC = 130 bpm. O abdome é flácido, indolor a palpação. Toque retal é positivo para melena. Diante do provável diagnóstico e considerando os índices de estratificação de risco, assinale a alternativa correta:

- A) Shock index = 1,6 e pontuação de Glasgow-Blatchford de pelo menos 4 pontos indicam a necessidade de endoscopia digestiva alta em até 36 horas da admissão hospitalar.
- B) Shock index = 1,6 e pontuação de Glasgow-Blatchford de pelo menos 7 pontos indicam a necessidade de endoscopia digestiva alta urgente após a estabilização hemodinâmica.
- C) Shock index = 1,8 e pontuação de Glasgow-Blatchford de pelo menos 3 pontos indicam a realização de tomografia de crânio seguida de angiotomografia do abdome.

D) Shock index = 1,8 e pontuação de Glasgow-Blatchford de pelo menos 12 pontos indicam a necessidade de tomografia do abdome com contraste endovenoso.

66 - Mulher de 60 anos refere abaulamento doloroso na região inguinal direita há 3 meses, que desaparece quando se deita. Ao exame físico, observa-se presença de hérnia femoral redutível. Qual é a estrutura anatômica determinante para a diferenciação clínica entre as hérnias inguinais e femorais?

- A) Anel inguinal interno.
- B) Fáscia *transversalis*.
- C) Ligamento inguinal.
- D) Vasos epigástricos inferiores.

67 - Homem de 32 anos, com antecedente pessoal de apendicectomia aos 20 anos, realizada através de incisão de McBurney, dá entrada na emergência cirúrgica de um hospital terciário com queixa de dor e distensão abdominal há 3 dias, associadas a vômitos. Não evacua e não elimina flatos há 5 dias. Considerando-se a hipótese de abdome agudo obstrutivo secundário a bridas, assinale a alternativa correta em relação ao tratamento:

- A) O tratamento não operatório pode ser tentado desde que o paciente esteja estável hemodinamicamente, não apresente sinais de peritonite ao exame físico e a dosagem da PCR < 5 mg/dL.
- B) A adesiólise cirúrgica (lise cirúrgica das bridas) é o procedimento de escolha e não pode ser realizada por via laparoscópica devido ao risco de lesão inadvertida de alças.
- C) A cirurgia laparoscópica pode ser indicada e apresenta menor morbidade, apesar do risco mais elevado de lesão intestinal quando comparada a via laparotômica.
- D) São sinais de falência do tratamento clínico: persistência da dor abdominal por mais de 72 horas, drenagem de conteúdo de estase pela sonda nasogástrica de 200 mL em 24 horas e sinais de peritonite ao exame físico.

68 - Uma mulher, de 45 anos, apresenta hiperparatireoidismo primário sintomático. Durante a cirurgia, nota-se que todas as quatro glândulas estão marcadamente aumentadas. Qual das opções a seguir é a melhor recomendação?

- A) Remoção das quatro glândulas com autotransplante de doze pedaços de tecido paratireoidiano de um milímetro no antebraço e criopreservação.
- B) Remoção das quatro glândulas com reposição oral de cálcio e criopreservação das glândulas ressecadas.
- C) Biópsia das quatro glândulas sem removê-las e aguardar resultado do exame anatomopatológico para reoperação.
- D) Remoção de uma glândula e biópsia das outras três, aguardando o resultado do exame anatomopatológico para reoperação.

69 - Mulher de 48 anos, realizou endoscopia digestiva alta, que evidenciou uma lesão ovalada, projetada para o lúmen gástrico, recoberto por mucosa de aspecto normal, de consistência firme

ao toque da pinça, medindo aproximadamente 3cm de diâmetro e localizada na parede posterior do corpo, sugestiva de tumor estromal. Considerando-se esta hipótese diagnóstica, é correto afirmar:

- A) Níveis elevados do marcador HER 2 confirmam o diagnóstico.
- B) A mutação no proto-oncogene c-Kit está presente em 95% destas neoplasias.
- C) A gastrectomia total com linfadenectomia é a cirurgia padrão para o tratamento.
- D) A classificação em tipos intestinal e difuso tem importância na determinação prognóstica.

70 - Um homem de 60 anos, tabagista, realizou endoscopia digestiva alta para investigação de sintomas dispépticos e foi diagnosticado com uma neoplasia de antro. Para o tratamento curativo do adenocarcinoma gástrico, são utilizadas várias modalidades terapêuticas, de forma isolada ou associadas. Em relação ao tema, assinale a alternativa correta:

- A) O tratamento atual de escolha consiste em esquema perioperatório com quimioterapia e cirurgia com linfadenectomia.
- B) Radioterapia neoadjuvante do abdome e gastrectomia é o tratamento de escolha para tumores locorregionais.
- C) Gastrectomia com ressecção linfonodal seguida de radioterapia adjuvante é preconizada para as neoplasias do antro.
- D) Quimioterapia com gastrectomia parcial vertical sem linfadenectomia é uma alternativa para pacientes com status performance ruim.

71 - Uma mulher de 73 anos da entrada no pronto-socorro devido a febre alta (39°C), dor no quadrante superior direito e icterícia de início agudo. Nas últimas 12 horas, apresentou rebaixamento do nível de consciência e hipotensão (PA 80X50mmHg), necessitando do uso de noradrenalina. Exames laboratoriais: leucograma = 14.000/mm² com neutrofilia, fosfatase alcalina = 600 U/L, bilirrubina total = 6,0 mg/dL. A ultrassonografia do abdome mostra dilatação do ducto colédoco com cálculo impactado ao nível da ampola de Vater. De acordo com os critérios de Tóquio 2018, qual é o diagnóstico classificação e o manejo terapêutico correto?

- A) Colangite moderada; internação em UTI e drenagem endoscópica precoce após estabilização.
- B) Colangite moderada; antibioticoterapia por via intravenosa por 7 dias e drenagem endoscópica eletiva após estabilização hemodinâmica.
- C) Colangite grave; intervenção hemodinâmica imediata com suporte intensivo, antibioticoterapia e drenagem biliar emergencial por CPRE.
- D) Colangite grave; antibioticoterapia com atenção a agentes multirresistentes e drenagem cirúrgica imediata.

72 - Um homem de 45 anos é encaminhado ao ambulatório do cirurgião após investigação por diarreia crônica e perda ponderal de 10kg em 6 meses. Ele também refere episódios intermitentes de rubor facial e sensação de calor. Exame físico sem alterações. Exames laboratoriais mostram hipocalemia e acidose metabólica hiperclorêmica. A tomografia computadorizada revela massa sólida hipervascular de 2 cm no corpo do pâncreas. Não há evidências de metástases à distância. Com base no quadro clínico e nos achados complementares, qual diagnóstico é mais provável e qual deve ser o plano terapêutico?

- A) VIPoma; controle de eletrólitos no pré-operatório e tratamento cirúrgico da lesão.
- B) Glucagonoma; ressecção completa da lesão e controle intensivo de hiperglicemia.
- C) Insulinoma; monitoramento clínico exclusivo devido ao pequeno tamanho da lesão.
- D) Gastrinoma; administração de altas doses de IBP seguida de quimioterapia neoadjuvante.

73 - Paciente masculino, 20 anos, história de acidente motociclístico em alta velocidade na rodovia, tendo sido ejetado por cerca de 5 metros, com traumatismo cranioencefálico e torácico. Apresenta-se confuso, dispneico, queixando-se de falta de ar. Ao exame físico, apresenta ausculta abolida em hemitórax esquerdo, distensão de veias do pescoço, com PA = 80x50 mmHg, FC = 130 bpm, FR = 40 ipm e saturação de O₂ de 75% com máscara de oxigênio a 12 litros por minuto. A conduta imediata durante o atendimento inicial deve ser:

- A) Drenagem de tórax.
- B) Descompressão torácica.
- C) Toracotomia exploradora.
- D) Intubação orotraqueal.

74 - Paciente feminino, 26 anos, história de acidente automobilístico na rodovia em alta velocidade com colisão frontal. Apresenta marca do cinto de segurança em abdome, queixando-se de dor abdominal. O exame físico demonstra dor à palpação profunda de mesogástrio, sem sinais de irritação peritoneal. Hemodinamicamente normal, com PA = 110x70mmHg, FC = 96 bpm, FR = 18 ipm e saturação de O₂ 97% em ar ambiente. A tomografia abdominal evidenciou uma lesão esplênica Grau IV, com escape de contraste em ramo polar inferior do baço, com moderada quantidade de líquido livre em cavidade peritoneal. Diante do achado tomográfico e do exame físico, qual a melhor conduta?

- A) Laparotomia exploradora com esplenectomia total.
- B) Videolaparoscopia exploradora com esplenectomia total.
- C) Arteriografia com embolização de ramo de artéria esplênica.
- D) Tratamento expectante com exame físico seriado em Unidade de Terapia Intensiva.

75 - Um jovem de 22 anos é levado a um Hospital de Trauma após acidente de moto com anteparo fixo. Queixa-se de dor em região de dorso. Durante a avaliação inicial, apresentou um episódio de hematúria franca. Em função do exame físico, foi solicitado tomografia de corpo inteiro. Dentre as condições abaixo, a única que seria indicação imediata de laparotomia exploradora frente ao diagnóstico de lesão renal traumática é:

- A) Aparecimento de instabilidade hemodinâmica.
- B) Achado tomográfico de lesão de ducto coletor.
- C) Achado tomográfico de trombose da artéria renal.
- D) Persistência de hematúria após iniciar irrigação vesical.

76 - Uma jovem vítima de acidente de moto, atendida pela equipe pré-hospitalar, é conduzida até a emergência de um hospital terciário para o atendimento inicial. O rolamento em bloco é uma

parte fundamental no atendimento à vítima politraumatizada. Sobre ele, é correto afirmar:

- A) Só deve ser realizado quando o paciente chega à emergência com os dispositivos prancha rígida e colar cervical e, atendido pela equipe pré-hospitalar.
- B) Deve ser realizado ao final da avaliação secundária, exceto quando se busca fonte de sangramento ativo no dorso.
- C) Deve ser realizado assim que o paciente chega no setor de emergência do hospital para que a prancha rígida seja retirada o mais rápido possível.
- D) Deve ser realizado após a avaliação primária, depois que todas as lesões que pudessem levar risco à vida do paciente terem sido diagnosticadas e tratadas.

77 - Um homem de 41 anos, vítima de ferimento por arma branca em região cervical direita e hemitórax esquerdo, é atendido em uma Unidade Primária de Atendimento de Emergência, com sinais clínicos sugestivos de choque hemorrágico. Após iniciar reposição volêmica com Ringer Lactato e infusão de 1,0 grama de Ácido Tranexâmico, iniciou a transferência a um Hospital Quaternário, Nível I de Trauma. Na chegada a este Hospital de Trauma, durante a avaliação inicial, o médico assistente evidencia Shock Index de 1,2 e ABC score de 3 pontos. Neste momento, com relação ao tratamento do choque hemorrágico, a conduta deveria iniciar a ressuscitação hemodinâmica com:

- A) Concentrado de Hemáceas; Soro Albuminado; Plasma Fresco; Plaquetas.
- B) Concentrado de Hemáceas; Solução Salina Hipertônica; Plasma Fresco.
- C) Concentrado de Hemáceas; Plasma Fresco; Plaquetas; Crioprecipitado.
- D) Concentrado de Hemáceas; Soro Albuminado; Plasmalyte; Plaquetas.

78 - Um homem negro de 62 anos se apresenta à clínica para seu exame anual do pé diabético. Ele reclama de unhas grossas e amareladas que esfregam em seus sapatos. O exame físico dos membros inferiores revela diminuição da sensibilidade em ambos os pés, pulsos poplíteos e pediosos palpáveis. Há um pequeno nevo preto em seu calcanhar direito que exibe um padrão dermatoscópico de crista paralela. Qual dos seguintes tipos de câncer de pele pode estar associado com o padrão dermatoscópico descrito?

- A) Melanoma nodular.
- B) Melanoma lentiginoso acral.
- C) Melanoma lentigo maligno.
- D) Melanoma extensivo superficial.

79 - Homem de 57 anos dá entrada no pronto-atendimento com queixa de dor abdominal em quadrante inferior esquerdo, febre aferida e diarreia com raias de sangue há 3 dias. Ao exame físico apresenta-se em regular estado geral, PAM = 65 mmHg, FC = 98 bpm, TAx = 37,9°C, abdome globoso, doloroso à palpação difusa, com sinais de peritonite. Exames laboratoriais: Leucometria = 17000/mm³ (88% de segmentados), PCR = 32 mg/dL. Após realização de tomografia do abdome, recebe o diagnóstico de diverticulite aguda complicada (classificação de Hinchey II). Assinale a alternativa que indica a provável necessidade de tratamento cirúrgico:

- A) Presença de peritonite.
- B) Leucocitose maior que 15000/mm³.
- C) Temperatura axilar maior que 36,5°C.
- D) PCR maior que 30 mg/dL.

80 - Mulher de 48 anos, em programação cirúrgica para videocolecistectomia devido a colelitíase sintomática, dá entrada na emergência cirúrgica de um hospital terciário devido a dor refratária em andar superior do abdome e vômitos há dois dias. Exames laboratoriais da admissão: leucometria = 15600/mm³ (valor de referência até 11000/mm³), amilase 1730 U/l (até 100 U/l), lipase = 3200 (até 60 U/l), PCR = 36 mg/dL (até 0,5 mg/dL). Considerando-se o diagnóstico, assinale a alternativa correta:

- A) A reposição fluídica moderadamente agressiva (1,5 mL/kg/h) com ringer lactato deve ser iniciada.
- B) O aumento da proteína C reativa deve indicar o início da antibioticoterapia com carbapenêmicos.
- C) O uso de analgésicos opioides e anti-inflamatórios não esteroidais é contraindicado na pancreatite aguda biliar.
- D) A dieta parenteral deve ser iniciada o mais precocemente possível, mesmo na ausência de contraindicações à dieta por via oral.

GABARITO

1	11	21	31	41	51	61	71
C	D	C	D	X	A	C	C
2	12	22	32	42	52	62	72
B	C	B	B	B	D	B	A
3	13	23	33	43	53	63	73
A	B	D	C	A	B	A	B
4	14	24	34	44	54	64	74
C	A	C	A	C	C	C	C
5	15	25	35	45	55	65	75
X	D	B	X	D	B	B	A
6	16	26	36	46	56	66	76
A	B	A	A	C	D	C	B
7	17	27	37	47	57	67	77
B	C	C	C	A	D	C	C
8	18	28	38	48	58	68	78
X	B	C	B	D	A	A	B
9	19	29	39	49	59	69	79
C	B	D	D	A	A	B	A
10	20	30	40	50	60	70	80
B	A	A	A	C	B	A	A

QUESTÃO ANULADA = X